



Chirurgical

Procédures

[WARNING] Attention : la loi fédérale restreint la vente de cet appareil par ou sur ordonnance d'un médecin.

À PROPOS DE CE DOCUMENT

Ce document fait partie du mode d'emploi (IFU) du système Barostim™. La notice d'utilisation complète comprend :

Présentation du système	900133-001
Procédures chirurgicales	900133-002
Programmation	900133-003
Imagerie par résonance magnétique (IRM)	900133-004
Instructions aux patients	900133-005

Les documents IFU sont disponibles sur www.cvrx.com/ifu.

2 | 900133-002 Rév. D IFU Procédures chirurgicales

Table des matières

À propos de ce document	2
1 Préparation de l'implant	4
[WARNING] AVERTISSEMENTS et PRÉCAUTIONS	5
Avant l'implantation	5
Matériaux recommandés pour l'implantation	5
Matériel nécessaire	6
Préparation chirurgicale	6
2 Procédure d'implantation	9
Mise à jour clinique	10
Anesthésie	11
Placement des prospects	13
Placement des IPG	13
Connecter le câble	14
Cartographie et amp; Fixation de la sonde	16
Positionnement final de la sonde et fixation	18
3 Remplacement de l'IPG	21
Recommandations	22
Matériel nécessaire	22
Couverture des antibiotiques	22
Explantation d'IPG appauvri	22
Placement des IPG	23
4 Procédures d'explication	24
Recommandations	25
Matériaux recommandés	25
Couverture antibiotique – Non infecté	25
Couverture antibiotique – Infectés	25
Explantation IPG	25
Explantation CSL	26

1 Préparation des implants

4 | 900133-002 Rév. D IFU Procédures chirurgicales

[WARNING] AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Pour une liste complète des avertissements et des précautions concernant le système, y compris les procédures d'implantation, veuillez consulter la présentation du système 900133-001 (disponible sur www.cvr.com/ifu).

AVANT L'IMPLANTATION

Une échographie duplex préopératoire formelle devrait être nécessaire.

- Confirmer l'absence d'anatomie artérielle complexe, telle que des plis, des boucles et des spirales carotidiennes, qui compromettraient la procédure d'implantation.
- Vérifier l'absence de toute sténose entraînant une réduction supérieure à 50 % du diamètre des artères carotides.
- Vérifier l'absence de plaques ulcéreuses.
- Vérifiez que le niveau de la bifurcation carotidienne est facilement accessible à partir des incisions cervicales standard.
- Déterminer s'il existe des variantes anatomiques qui pourraient suggérer qu'une imagerie supplémentaire serait utile pour la planification du traitement.
- Autres variantes ou conditions qui élimineraient le patient comme candidat chirurgical.

Assurez-vous qu'un générateur d'impulsions implantable (IPG) et une sonde du sinus carotidien (CSL ou sonde) de secours sont disponibles au cas où la stérilité du premier IPG serait compromise ou si le dispositif serait endommagé pendant l'intervention chirurgicale.

Assurez-vous qu'un système de programmation de secours est disponible au cas où le système principal serait endommagé ou deviendrait non opérationnel.

Il est recommandé aux médecins de vérifier la compatibilité avec le(s) dispositif(s) implanté(s) au moment de l'implantation du système Barostim. Assurez-vous que les instruments appropriés pour surveiller le comportement du dispositif actuellement implanté sont présents.

MATÉRIAUX RECOMMANDÉS POUR L'IMPLANTATION

- Une table ou un support à l'extérieur du champ opératoire stérile pour maintenir le système programmeur.
- Un équipement de surveillance de la pression artérielle (tel qu'une ligne artérielle) pour évaluer les changements de pression artérielle pendant les tests thérapeutiques.